

CAPÍTULO 14.6

Artritis Séptica

PERFIL EUNACOM 1.04.2.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **artritis séptica** es una de las emergencias médicas más críticas en reumatología e infectología. Se define como la invasión del espacio articular por microorganismos patógenos, lo que desencadena una respuesta inflamatoria severa capaz de destruir el cartílago y el hueso subyacente en pocas horas o días.

Clínica y Presentación

La forma de presentación clásica es una **monoartritis aguda**. El paciente típicamente consulta por:

- **Dolor articular intenso**, de inicio brusco.
- **Aumento de volumen** (derrame articular).
- **Calor y eritema** local.
- **Limitación funcional severa** (dolor a la movilización pasiva y activa).

En casos graves o pacientes inmunocomprometidos, el cuadro puede progresar a una **Sepsis** o incluso un **shock séptico**, manifestándose con fiebre alta, escalofríos, compromiso del estado general, hipotensión y taquicardia.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante toda **monoartritis aguda** (una sola articulación inflamada), el primer diagnóstico a descartar por su gravedad es la **artritis séptica**. El segundo diagnóstico diferencial frecuente es la **Gota** (artritis por microcristales).

Diagnóstico

El diagnóstico definitivo se realiza mediante el estudio del **líquido sinovial**, obtenido a través de una **artrocentesis** (punción articular).

- **Estudio del líquido:** El líquido suele ser purulento, con una celularidad muy elevada (habitualmente >50,000 leucocitos/mm³ con predominio de polimorfonucleares).
- **Tinción de Gram y Cultivo:** Es fundamental para identificar el agente causal y su sensibilidad antibiótica.
- **Hemocultivos:** Deben solicitarse siempre, ya que la vía de llegada más común al espacio articular es la hematógena.

Pruebas de Imagen

Aunque el diagnóstico es clínico y por punción, la **radiografía** se solicita de forma rutinaria. - Inicialmente, puede ser normal o mostrar solo aumento de partes blandas. - En etapas avanzadas, es una causa de **artritis erosiva**, similar a la **Artritis Reumatoide**, pero con la diferencia crítica de que la séptica es monoarticular y de evolución rápida.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de la destrucción articular radica en la liberación de enzimas proteolíticas tanto por las bacterias como por los neutrófilos del huésped, lo que degrada el colágeno y la matriz cartilaginosa rápidamente.

Manejo Terapéutico

El tratamiento de la artritis séptica es una **urgencia médica** que combina dos pilares fundamentales: **antibioticoterapia endovenosa** y **drenaje quirúrgico**.

1. Drenaje de la Articulación

Es imperativo evacuar el material purulento y los detritos inflamatorios para disminuir la presión intraarticular y la carga bacteriana. - **Artroscopia:** Es el método de elección siempre que esté disponible, ya que permite una visualización directa, un lavado profuso y tiene una recuperación más rápida. - **Cirugía abierta (Artrotomía):** Se reserva para articulaciones de difícil acceso

artroscópico (como la cadera en adultos) o cuando la artroscopia no está disponible.

2. Tratamiento Antibiótico

Se debe iniciar de forma **empírica e inmediata** tras la toma de cultivos. La elección del fármaco depende de la sospecha del germen:

TABLA 14.6.1: ESCENARIO CLÍNICO VS GERMEN SOSPECHADO

ESCENARIO CLÍNICO	GERMEN SOSPECHADO	ANTIBIÓTICO DE ELECCIÓN
Empírico (Desconocido)	<i>S. aureus</i> (incluyendo MRSA)	Vancomicina IV
Cocos Gram (+) en Gram	<i>Staphylococcus aureus</i> sensible	Cloxacilina o Cefazolina IV
Resistencia a Meticilina	<i>S. aureus</i> resistente (MRSA)	Vancomicina IV (alternativa: Linezolid)
Sospecha de ETS / Adulto joven	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Ceftriaxona IV
Bacilos Gram (-)	<i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i>	Según antibiograma (Ceftazidima, Carbapenémicos)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca se debe esperar el resultado del antibiograma para iniciar el tratamiento. Se inicia con **Vancomicina** para cubrir el estafilococo resistente y luego se realiza el "desescalamiento" (ajuste a un antibiótico de espectro más dirigido) una vez se conozca la sensibilidad del germen.

Artritis Gonocócica

Es una variante importante en adultos jóvenes sexualmente activos. A diferencia de la artritis por *S. aureus*, esta puede presentarse como un cuadro de **tenosinovitis, dermatitis (pápulas o pústulas) y poliartralgias migratorias** antes de establecerse como una monoartritis. El tratamiento de elección es siempre la **Ceftriaxona**.

Resumen de Perlas EUNACOM

- **Emergencia:** El retraso en el tratamiento produce destrucción articular irreversible en < 48 horas.
- **Vía de infección:** La más frecuente es la hematógena.
- **Tratamiento:** Siempre es **Antibióticos IV + Drenaje**. El antibiótico solo no es suficiente debido a la mala penetración en abscesos y la acidez del medio purulento.
- **Microbiología:** El germen más frecuente globalmente es el *Staphylococcus aureus*. En jóvenes, considerar siempre el Gonococo.

Insuficiencia Cardíaca: Generalidades Shock

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con monoartritis aguda de rodilla. Punción muestra cocáceas gram positivas. Aún no tiene antibiograma. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico más apropiado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Artritis Séptica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La artritis séptica se presenta como monoartritis aguda y puede evolucionar a sepsis
- Es una artritis erosiva junto con la artritis reumatoide
- El tratamiento es urgente: antibióticos EV + drenaje quirúrgico (artroscopia o cirugía abierta)
- Tratamiento empírico: vancomicina (cubrir *S. aureus* incluyendo SAMR)
- Para gonococo: ceftriaxona EV
- Si el antibiograma muestra sensibilidad, se baja de vancomicina a cloxacilina o cefazolina EV

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARTRITIS SÉPTICA)**PREGUNTA 1**

Paciente con monoartritis aguda de rodilla. Punción muestra cocáceas gram positivas. Aún no tiene antibiograma. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico más apropiado?

- A)** Cefazolina endovenosa
- B)** Ceftriaxona endovenosa
- C)** Vancomicina endovenosa
- D)** Cloxacilina oral
- E)** Amoxicilina-ácido clavulánico oral

PREGUNTA 2

Adulto joven sexualmente activo con monoartritis aguda. La tinción de gram muestra diplococos gram negativos. ¿Cuál es el antibiótico de elección?

- A)** Vancomicina
- B)** Cloxacilina
- C)** Ceftriaxona
- D)** Ciprofloxacino
- E)** Linezolid

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tratamiento completo de la artritis séptica?

- A)** Antibióticos orales ambulatorios
- B)** Antibióticos EV + drenaje quirúrgico
- C)** Corticoides EV + antibióticos orales
- D)** AINEs + punción evacuadora
- E)** Antibióticos EV sin drenaje

RESUMEN: ARTRITIS SÉPTICA

La artritis séptica se presenta como monoartritis aguda y en casos graves puede evolucionar a sepsis con fiebre y shock séptico. El diagnóstico se confirma con la punción articular que demuestra bacterias en el líquido sinovial. Es una artritis erosiva (junto con la artritis reumatoide). El tratamiento es urgente: antibióticos endovenosos más drenaje quirúrgico (artroscópico si disponible, o cirugía abierta). La elección del antibiótico depende del germen: para *S. aureus* sensible se usa cefazolina o cloxacilina EV; para *S. aureus* resistente, vancomicina; para germen desconocido el tratamiento empírico es vancomicina (cubrir SAMR); para gonococo se usa ceftriaxona EV. En la práctica, al no tener aún el antibiograma, se inicia vancomicina empíricamente y luego se ajusta según sensibilidad. Si resulta sensible, se baja a cloxacilina o cefazolina EV.